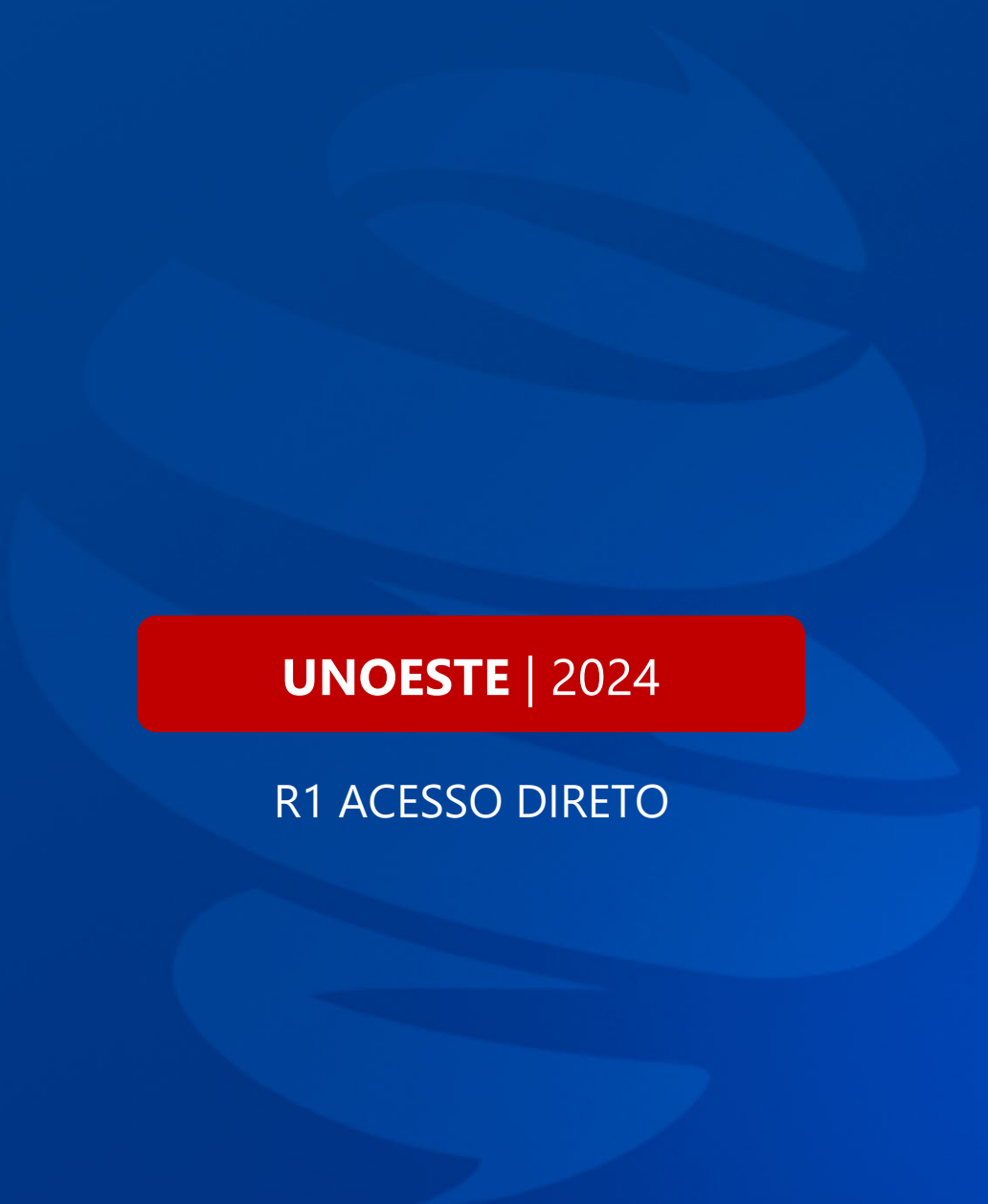




UNOESTE | 2024

R1 ACESSO DIRETO

1) O bloqueio de segundo grau Mobitz II caracteriza-se pela presença de

- A) intervalo PR constante e ondas P bloqueadas aleatoriamente, e o tratamento de escolha é a colocação de marcapasso.
- B) intervalo PR maior que 200 ms, ondas P bloqueadas e o tratamento de escolha é a colocação de marcapasso.
- C) condução apenas a cada três ou mais ondas P e o tratamento de escolha é feito com uso de atropina 1 mg.
- D) aumento do intervalo PR progressivamente, e o tratamento de escolha é a colocação de marcapasso.
- E) diminuição do intervalo PR, e o tratamento de escolha é feito com uso de atropina 1 mg.

2) A pesquisa de antígeno para Legionella e pneumococo na urina como investigação etiológica de pneumonia de comunidade grave deve ser feita em pacientes com

- A) DPOC.
- B) pneumopatia estrutural.
- C) derrame pleural.
- D) etilista.
- E) asplenia.

3) Paciente de 65 anos sem comorbidades apresenta o seguinte liquor: pressão de abertura aumentada, 1235 células com predomínio de neutrófilos, glicose 27 mg/dL e proteínas 121 mg/dL. Neste momento, o tratamento deve ser feito com

- A) ceftriaxone.
- B) ceftriaxone associado a ampicilina.
- C) aciclovir.
- D) penicilina cristalina.
- E) apenas suporte clínico.

4) Com relação à morte encefálica, assinale a alternativa correta.

- A) O estímulo doloroso deve ser realizado exclusivamente em leito ungueal.
- B) O reflexo córneo-palpebral avalia o mesencéfalo - II e III/aferente e eferente.
- C) O reflexo oculomotor é avaliado pela presença de pupilas médias ou midriáticas, fixas e ausência de contração pupilar.
- D) O reflexo óculo-vestibular deve ser feito com infusão de líquido aquecido.

E) Para realização do reflexo óculo-vestibular, a cabeceira deve estar elevada a 90 graus.

5) Assinale a alternativa que contém a correta associação entre tóxico e alteração do sinal vital mais prevalente.

- A) Maconha e taquipneia.
- B) Etanol e taquicardia.
- C) Monóxido de carbono e hipotermia.
- D) Cocaína e hipotensão.
- E) Opioide e bradipneia.

6) Com relação aos acidentes com animais peçonhentos, pode-se afirmar, corretamente, que

- A) as picadas de escorpião acontecem mais frequentemente nas mãos.
- B) os acidentes crotálicos são mais prevalentes que os botrópicos.
- C) a ocorrência de acidente laquétrico restringe-se à região Nordeste do Brasil.
- D) o veneno elapídico tem ação predominante hemorrágica.
- E) anualmente, temos em média 10 óbitos por picada de abelhas no Brasil.

7) É considerado fator de risco para o desenvolvimento de dengue hemorrágica:

- A) a presença de hipertensão arterial concomitante.
- B) a presença da variante HLA classe III.
- C) a obesidade.
- D) o gênero masculino.
- E) idade menor do que 45 anos.

8) Espera-se encontrar o líquido sinovial da artrite gotosa com as seguintes características:

- A) aparência transparente, coloração amarelada, alta viscosidade, 20 mil leucócitos/mm³, 75% de polimorfonucleares e pesquisa de cristais positiva.
- B) aparência translúcida, coloração amarelada, baixa viscosidade, 20 mil leucócitos/mm³, 67% de polimorfonucleares e pesquisa de cristais positiva.
- C) aparência translúcida, coloração clara, alta viscosidade, 200 mil leucócitos/mm³, 80% de polimorfonucleares e pesquisa de cristais positiva.
- D) aparência translúcida, coloração amarelada, baixa viscosidade, 30 mil leucócitos/mm³, 67% de polimorfonucleares e pesquisa de cristais negativa.
- E) aparência translúcida, coloração clara, alta viscosidade, 100 mil leucócitos/mm³, 67% de polimorfonucleares e pesquisa de cristais negativa.

9) Com relação às vasculites primárias, pode-se afirmar, corretamente, que um exemplo de acometimento de grandes vasos é a

- A) poliarterite nodosa.
- B) doença de Kawasaki.

- C) púrpura de Henoch-Schonlein.
- D) arterite de Takayasu.
- E) síndrome de Churg-Strauss.

10) Os principais distúrbios hidroeletrólíticos encontrados em pacientes oncológicos com quadro de síndrome de lise tumoral são:

- A) hiporuricemia, hipofosfatemia, hipocalcemia e hipercalemia.
- B) hiporuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipercalemia.
- C) hiporuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia e hipocalcemia.
- D) hiperuricemia, hipofosfatemia, hipocalcemia e hipocalcemia.
- E) hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipercalemia.

11) Um paciente idoso saudável tem como meta de controle do diabetes melito:

- A) a glicemia de jejum e pré-prandial entre 90 e 150 mg/dL.
- B) a glicemia, ao deitar, menor que 180 mg/dL.
- C) a HbA1c menor que 7,5%.
- D) um tempo de hipoglicemia (menor que 70 mg/dL) menor do que 1%.
- E) um tempo no alvo (70-180 mg/dL) maior que 60%.

12) Considerando-se as atualizações referentes à hipertensão arterial, pode-se afirmar, corretamente, que

- A) a pré-hipertensão é definida por pressão sistólica entre 130 e 139 mmHg e/ou diastólica entre 85 e 89 mmHg, para medida em consultório.
- B) a pressão normal ótima é aquela menor ou igual a 118 por 78 mmHg.
- C) para medições em consultório, a definição de hipertensão arterial continua sendo de 145 mmHg por 95 mmHg.
- D) na monitorização residencial da pressão arterial, a definição de hipertensão arterial continua sendo maior ou igual a 130 por 80 mmHg.
- E) a faixa entre 119-129 e 79-84 passa a ser considerada normal, mas não ótima, e obriga o acompanhamento.

13) Com relação à insuficiência cardíaca perfil B, pode-se afirmar, corretamente, que

- A) o uso de diuréticos deve ser evitado.
- B) o uso parenteral de vasodilatador está indicado, por aumentar a pré e a pós-carga.
- C) a taxa de óbito ou necessidade de transplante cardíaco é o dobro das demais classes comparativamente.
- D) ela se manifesta com congestão e boa perfusão periférica.
- E) raramente há aumento de níveis de BNP e NT-pro-BNP.

14) Na avaliação da bioquímica urinária, um paciente encontra-se com sódio urinário de 8 mEq/L e uma fração de excreção de sódio de 9%. Mais provavelmente, trata-se de quadro

- A) pré-renal por hiperplasia benigna de próstata.
- B) pré-renal por uso de contraste iodado.
- C) renal por hipertensão maligna.
- D) renal por sepse.
- E) pós-renal por bexiga neurogênica.

15) Com relação à febre maculosa, assinale a alternativa correta.

- A) Doxaciclina deve ser introduzida imediatamente e mantida por 30 dias.
- B) A profilaxia está indicada caso o paciente relate ter achado carrapato aderido ao corpo.
- C) Hepatoesplenomegalia surge já no primeiro dia de sintomas, em mulheres especialmente.
- D) Raramente há febre associada.
- E) O exantema em palmas e mãos, em geral, aparece entre o terceiro e o quinto dia do início dos sintomas.

16) Considerando o escore CHAD2DS2-VASc, assinale a alternativa correta.

- A) Escore maior que 5 há risco anual de acidente vascular cerebral isquêmico por fibrilação ventricular na ordem de 5,4 a 12,2%.
- B) Idade maior que 70 anos confere pontuação 2.
- C) A presença de insuficiência cardíaca confere pontuação 3.
- D) A presença de hipertensão arterial confere pontuação 2.
- E) Gênero masculino confere pontuação 1.

17) É critério de resolução da cetoacidose diabética:

- A) bicarbonato maior ou igual a 14 e anión gap menor ou igual a 11.
- B) pH maior que 7,3 e bicarbonato maior ou igual a 15.
- C) pH maior que 7,2 e anión gap menor ou igual a 12.
- D) bicarbonato maior ou igual a 14 e glicemia capilar menor que 300 mg/dL.
- E) glicemia capilar menor que 300 mg/dL e anión gap menor ou igual a 11.

18) Risco alto (odds ratio >10) para tromboembolismo pulmonar é:

- A) gravidez.
- B) doença autoimune.
- C) artroplastia de quadril.
- D) uso de anticoncepcional oral.
- E) quimioterapia.

19) Considerando-se as doenças infecciosas, assinale a alternativa correta.

- A) O diagnóstico sorológico da leptospirose pode ser feito de 7-10 dias depois do início dos sintomas.

- B) A identificação de manchas de Koplik permitem o diagnóstico de mononucleose infecciosa.
- C) Em média, o período de incubação do sarampo é de 2-5 dias.
- D) Sífilis terciária pode surgir entre 1 e 40 anos após o início da infecção.
- E) A menor transmissibilidade da coqueluche ocorre durante a fase catarral.

20) A reanimação cardiopulmonar de indivíduos adultos nos impõe a utilização de desfibrilação e medicamentos. Assinale a alternativa correta considerando o ritmo de fibrilação ventricular.

- A) Epinefrina e amiodarona podem ser utilizadas a cada ciclo - 2 minutos de intervalo, antes da desfibrilação.
- B) Bicarbonato de sódio, na dose de 1 mEq/kg, pode ser utilizado sempre que a presença de acidose metabólica seja presumida.
- C) A dose inicial de amiodarona é de 150 mg.
- D) A epinefrina deve ser diluída em 9 mL de soro fisiológico antes da aplicação.
- E) A lidocaína tem sua dose máxima em 2,25 mg/kg.

21) Após identificados sinais de choque em pacientes politraumatizados o passo mais importante é a definição de sua causa para uma condução adequada das medidas de reanimação. No caso do choque hemorrágico, qual a medida mais eficaz para a restauração do retorno venoso do débito cardíaco e de uma perfusão tecidual adequada?

- A) Reposição volêmica com solução de eletrólitos isotônica.
- B) Reposição volêmica com solução colóide.
- C) Controle da fonte de sangramento.
- D) Administração de hemoderivados.
- E) Otimização da pressão arterial com uso de vasopressores.

22) Sobre o tamponamento cardíaco, assinale a alternativa correta.

- A) É encontrado mais comumente em pacientes vítimas de traumas torácicos fechados.
- B) Os principais sinais clínicos incluem: bradicardia, abafamento de bulhas e hipotensão com boa resposta a ressuscitação volêmica.
- C) O protocolo FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) não é capaz de identificar coleções pericárdicas.
- D) A pericardiocentese é o tratamento definitivo de escolha no manejo do tamponamento cardíaco.
- E) O pneumotórax hipertensivo pode ser confundido com um quadro de tamponamento cardíaco, mas pode ser diferenciado pela ausência de murmúrio vesicular e hipertimpanismo.

23) Um choque hemorrágico com perda volêmica estimada em 15 a 30%, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e frequência respiratória normais, bem como ausência

de alteração de nível de consciência e volume urinário normal é classificado como:

- A) ausente.
- B) leve.
- C) moderado.
- D) severo.
- E) extremo.

24) Qual dentre as alternativas descreve corretamente os sinais clínicos de um quadro de hemotórax maciço?

- A) Macicez à percussão, desvio traqueal e expansibilidade torácica preservada.
- B) Hipertimpanismo à percussão, traqueia centralizada e estase jugular.
- C) Murmúrio vesicular diminuído, macicez à percussão e estase jugular.
- D) Macicez à percussão, murmúrio vesicular diminuído e expansibilidade preservada.
- E) Murmúrio vesicular ausente, desvio traqueal e estase jugular.

25) Um homem de 45 anos foi vítima de ferimento por arma branca na região epigástrica e dá entrada na sala de trauma apresentando palidez cutaneomucosa (++/4+), PA 90x60 mmHg, FC 110 bpm e FR de 31 irpm. Ao exame físico não se evidencia saída de sangue do ferimento. No entanto, à palpação abdominal observa-se endurecimento (abdome em tábua) e o paciente se encontra agitado e pouco colaborativo. Assinale a alternativa que descreve a conduta diagnóstica mais adequada para o caso.

- A) Deve-se proceder com LPD (lavado peritoneal diagnóstico) pela sua alta especificidade na determinação de presença de sangue na cavidade. Caso apresente resultado negativo pode ser repetido após duas horas com o paciente anestesiado.
- B) Deve-se realizar o FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma) por ser um método menos invasivo e com alta sensibilidade para a presença de líquido na cavidade peritoneal.
- C) Deve-se proceder com analgesia e repetir o exame físico abdominal após um período de observação. O estado de agitação psicomotora relacionado ao estresse do evento traumático pode ser um fator de confusão, sendo preferível reavaliar o paciente após algumas horas.
- D) O paciente deve ser avaliado preferencialmente por tomografia computadorizada com contraste devido a sua melhor acurácia na avaliação das estruturas retroperitoneais e vasos abdominais.
- E) Este paciente deve ser conduzido imediatamente ao centro cirúrgico para laparotomia exploradora, sendo dispensável qualquer outro método diagnóstico ou propedêutico.

26) Nas situações em que há uma impossibilidade de intubação orotraqueal na sala de emergência, o cirurgião pode ser acionado para providenciar vias alternativas de acesso a traqueia visando à oxigenação e manutenção da vida. Com relação à cricotiroidostomia com agulha ou ventilação percutânea transtraqueal (VPT) em adultos, assinale a alternativa correta.

- A) Deve ser realizada com uma cânula de fino calibre (16 a 18 gauges).
- B) É realizada a partir da punção da traqueia, distalmente à cartilagem cricóidea.
- C) A ventilação deve ser realizada com um cateter fechado e oxigênio a 15 L/min.
- D) Com o tempo ocorre retenção de CO₂, motivo pelo qual deve ser utilizada apenas quando há falha na tentativa de realização de uma cricotireoidostomia cirúrgica.
- E) O risco de barotrauma e rotura pulmonar é maior em pacientes com obstruções glóticas.

27) Pacientes cirróticos podem ser avaliados com a classificação de Child-Pugh que estratifica o risco de acordo com uma pontuação baseada em exames laboratoriais e sintomas clínicos como a encefalopatia. Qual a classificação de um paciente com quadro de ascite leve controlada com diuréticos, encefalopatia estágio II, bilirrubina de 2 mg/dL, albumina sérica de 2,8 g/L, tempo de protrombina de 6 segundos e INR de 2,3?

- A) Child A (5 pontos).
- B) Child B (8 pontos).
- C) Child B com (10 pontos).
- D) Child C (12 pontos).
- E) Child C (15 pontos).

28) Considerando os riscos e benefícios da laparoscopia em pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, em relação à técnica convencional, assinale a alternativa correta.

- A) Os benefícios da cirurgia laparoscópica são essencialmente estéticos.
- B) A técnica laparoscópica está associada a maiores taxas de complicações respiratórias em comparação à laparotomia convencional.
- C) Há menos complicações relacionadas às feridas operatórias nas cirurgias laparoscópicas como hérnias e infecções.
- D) A principal causa de óbito nesse grupo é a isquemia miocárdica.
- E) Não há evidências de que a deambulação precoce no pós-operatório presente, nesse grupo de pacientes, diminuição das taxas de complicações tromboembólicas.

29) Assinale a alternativa correta em relação ao volvo colônico.

- A) Fatores de risco incluem constipação crônica, uso de psicotrópicos e envelhecimento, sendo a média de idade da apresentação em torno da sétima ou oitava década de vida.
- B) Qualquer porção do intestino grosso pode torcer, no entanto, o volvo é mais comum no cólon transverso.
- C) Os pacientes com volvo de sigmoide somente apresentam obstrução intestinal aguda, sendo esta a principal diferença em relação às obstruções malignas, que cursam com obstrução subaguda e progressiva.
- D) As radiografias abdominais mostram acentuada dilatação colônica, nível hidroaéreo na alça dilatada e na ampola retal.

E) O tratamento do volvo começa com a descompressão endoscópica e em seguida com a laparotomia de urgência (operação de Hartmann).

30) Assinale a alternativa que contém uma característica exclusiva da doença hemorroidária interna do terceiro grau.

- A) Prolapso necessitando redução manual.
- B) Hemorragia.
- C) Ausência de prolapso.
- D) Prolapso com redução espontânea.
- E) Prolapso sem possibilidade de redução.

31) A respeito de mecanismo de ação da terapia de feridas por pressão negativa (TFPN), assinale a alternativa correta.

- A) Demonstrou-se que a TFPN induz um aumento do fluxo sanguíneo local apesar de promover piora do edema.
- B) Esta técnica é indicada apenas para a terapia de feridas crônicas com infecção local.
- C) Um dos mecanismos de ação proposto é de que a TFPN remove exsudatos ao mesmo tempo em que mantém a ferida livre de umidade.
- D) Apesar da diminuição significativa do tempo de cicatrização a TFPN mostrou estar relacionada a uma maior contagem bacteriana nas feridas.
- E) O estresse tridimensional dentro das células, provocado pela TFPN, resulta em diminuição da densidade vascular e proliferação celular.

32) Que função exercem as células-tronco mesenquimais (CTMs) durante a fase proliferativa da cicatrização das feridas?

- A) Produção de TGF- β 3.
- B) Recrutamento de queratinócitos e fibroblastos da derme.
- C) Regulação da inflamação.
- D) Supressão do TNF.
- E) Bloqueio da proliferação de células T.

33) A hipertermia maligna (HM) é uma crise metabólica potencialmente fatal que se manifesta durante ou após a exposição a um anestésico deflagrador em indivíduos suscetíveis. Assinale a alternativa correta a respeito desta patologia.

- A) A suscetibilidade à HM é herdada como uma doença autossômica recessiva de penetrância incompleta.
- B) As taxas de mortalidade por HM têm aumentado nos últimos 15 anos como resultado de um maior número de procedimentos médicos sendo realizados com anestesia.
- C) Quando o indivíduo suscetível é exposto a um anestésico deflagrador ocorre uma liberação anormal de Ca^{2+} que provoca uma inibição prolongada dos filamentos musculares resultando em arreflexia e hipotonia.

D) A primeira medida após identificada a HM é a administração de dantrolene, 2,5 mg/kg seguido de hiperventilação com oxigênio a 100%.

E) Suspeita-se da suscetibilidade à HM pacientes com histórico familiar de HM, histórico pessoal de mialgia após exercício, tendência a desenvolvimento de febre e intolerância à cafeína.

34) Assinale a alternativa correta sobre a função, o local de produção e os principais estimulantes dos hormônios gastrointestinais.

A) A gastrina é um peptídeo produzido pelas células I duodenais e jejunais e atua como fator estimulador da produção de ácido gástrico.

B) A secretina produzida nas células S duodenais e jejunais, atua estimulando o fluxo e a alcalinidade biliar enquanto inibe a secreção do ácido gástrico e da gastrina.

C) A colecistoquinina é um hormônio secretado pelas células parietais gástricas que atua estimulando a secreção de bile pelo fígado enquanto aumenta o tônus do esfíncter de Oddi, resultando em uma concentração maior de sais biliares.

D) A somastostatina é produzida nas ilhotas pancreáticas e atua como principal estimulante da secreção do ácido gástrico enquanto estimula a secreção de água e eletrólitos pelo intestino delgado.

E) A motilina é secretada pelas células G do antro e do duodeno e atua inibindo a motilidade gastrointestinal com inibição concomitante do complexo motor migratório.

35) Sobre a apendicite aguda, assinale a alternativa correta.

A) O principal agente anaeróbio isolado na apendicite perfurada é a *Escherichia coli* seguido pelo *Bacteroides fragilis*.

B) O principal mecanismo de perfuração do apêndice é o acúmulo progressivo de líquido com consequente rotura devido à alta pressão intraluminal.

C) A dor abdominal inicial é visceral e ocorre devido a distensão do apêndice. Quando o processo inflamatório acomete a ponta do apêndice a dor assume padrão somático devido à irritação do peritônio parietal.

D) Pacientes com quadro de apendicite aguda apresentam leucocitose acentuada com desvio à esquerda. Contagens normais praticamente afastam o diagnóstico de abdome agudo inflamatório.

E) A tomografia é o exame de imagem mais comumente realizado para a confirmação diagnóstica podendo, no entanto, ser dispensada nos casos que se apresentam com quadro clínico típico, principalmente em mulheres férteis.

36) Suporte prolongado de peso em paciente imobilizados ou paralisados pode resultar em lesão tecidual extensa relacionada ao decúbito (úlceras de pressão). Assinale a alternativa correta.

A) Em modelos de isquemia, a pressão externa maior que 60 mmHg por 2 horas acarreta dano tecidual irreversível.

B) No estágio I a pele apresenta bolhas e outros pontos de rotura na derme.

- C) No estágio IV há perda total da espessura do tecido sem exposição óssea.
- D) A reconstrução com retalhos não é necessária na maioria das úlceras de pressão porque tendem a cicatrizar bem com fechamento primário ou enxerto.
- E) A úlcera isquiática uni ou bilateral se desenvolve em indivíduos imobilizados em posição supina ou semirreclinada.

37) Após a exérese cirúrgica de um tumor hepático, o cirurgião comunicou à equipe médica de que havia sido uma "ressecção R2". Qual o significado desta afirmação?

- A) Houve ressecção completa do tumor com margens microscópicas livres.
- B) Houve ressecção completa do tumor com margens microscópicas coincidentes.
- C) Houve ressecção completa do tumor com margens microscópicas comprometidas.
- D) Houve ressecção incompleta do tumor com margens macroscópicas comprometidas.
- E) Houve lesão da cápsula do tumor e, por isso, a ressecção foi considerada incompleta.

38) Sobre as lesões polipoides da vesícula biliar, assinale a alternativa correta.

- A) Pólipos de colesterol são comumente maiores do que 1 cm e geralmente únicos.
- B) Os adenomas maiores de 5 mm apresentam grande probabilidade para evolução maligna.
- C) A adenomiomatose é observada como uma lesão séssil, mais comumente localizada no fundo da vesícula e apresenta características microcísticas.
- D) Lesões polipoides assintomáticas menores do que 2,0 cm podem ser acompanhadas com ultrassonografias seriadas.
- E) A presença de lesão polipoide na vesícula biliar associada a cálculos não constitui indicação formal de colecistectomia.

39) Qual é a classificação de uma hérnia inguinal indireta recidivada à esquerda?

- A) Nyhus I.
- B) Nyhus IVB.
- C) Nyhus IIIB.
- D) Nyhus II.
- E) Nyhus IIIC.

40) Qual é a apresentação mais comum das fístulas perianais?

- A) Interesfincteriana.
- B) Transesfincteriana.
- C) Supraesfincteriana.
- D) Extraesfincteriana.
- E) Infraesfincteriana.

41) Primigesta com quadro de pré-eclâmpsia é submetida a parto cesariano de urgência, com 36 semanas de gestação, devido a sofrimento fetal agudo e presença de líquido meconial

espesso. Recém-nascido nasce hipotônico, apresentando movimentos respiratórios irregulares. Em relação aos procedimentos iniciais de reanimação para esse recém-nascido, assinale a alternativa correta.

- A) O cordão deve ser clampeado entre 1 e 3 minutos para garantir volemia adequada e estabilização cardiovascular.
- B) A massagem cardíaca é o primeiro passo da reanimação, devendo ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida, o "minuto de ouro", para garantir a perfusão do sistema nervoso central.
- C) Ventilação com pressão positiva está indicada se a respiração irregular for mantida após os passos iniciais de reanimação.
- D) O uso de CPAP está indicado para manter os alvéolos abertos, minimizando o risco de atelectasias e edema pulmonar.
- E) Saturação de oxigênio pré-ductal entre 70 e 80% nos primeiros 5 minutos de vida indica a necessidade de ventilação com oferta de oxigênio suplementar.

42) Recém-nascido a termo, nascido de parto normal, está em alojamento conjunto. No exame físico realizado com 12 horas de vida apresenta icterícia zona I leve, sem outras alterações. A conduta inicialmente indicada para esse caso é:

- A) observar e reavaliar a progressão da icterícia em 6 horas.
- B) iniciar fototerapia e reavaliar em 12 horas.
- C) colher bilirrubina total e frações.
- D) verificar a tipagem sanguínea da mãe e do recém-nascido para definir a conduta.
- E) hidratar e reavaliar em 12 horas.

43) Recém-nascido, filho de mãe com sorologia para toxoplasmose IgM e IgG positiva com avidéz baixa colhida no terceiro trimestre de gestação. Nasceu assintomático. Em relação à definição de caso, trata-se de toxoplasmose congênita

- A) ausente.
- B) improvável.
- C) possível.
- D) provável.
- E) comprovada.

44) Lactente com 50 dias de vida, menina, é levada ao pronto-atendimento com história de 1 dia de febre de 38,5 °C, sem outros sintomas associados. Ao exame físico, está em bom estado geral, sem alterações. O plantonista solicitou exames: Hemograma: Hb = 12,3 g/dL, Ht = 34%, leucócitos = 9800/mm³ (4% bastonetes, 45% segmentados, 46% linfócitos, 2% eosinófilos, 3% monócitos), plaquetas = 212000/mm³. Urina tipo I: pH = 5,5, densidade = 1025, glicose +, proteína ausente, nitrito +, esterase leucocitária +, leucócitos = 20/campo, eritrócitos = 2/campo. Frente a esses achados, a conduta indicada é:

- A) internar, colher urocultura e iniciar antibiótico parenteral.

- B) colher urocultura e dar alta com antibiótico oral.
- C) colher urocultura e orientar retorno em 48 horas para reavaliação e checar resultado.
- D) dar alta com antitérmico e reavaliar em 24 horas.
- E) iniciar antibiótico oral e orientar retorno se a febre persistir após 48 horas.

45) Menino de 9 anos de idade tem diagnóstico de asma moderada não controlada. A terapia atualmente indicada para controle mais efetivo da doença é:

- A) salbutamol inalatório como terapia de alívio.
- B) beclometasona inalatória na terapia de manutenção.
- C) metilprednisolona endovenoso nas crises de exacerbação.
- D) associação salbutamol inalatório e prednisona oral iniciados precocemente nas crises de exacerbação.
- E) associação budesonida e formoterol inalatório na terapia de alívio e de manutenção.

46) Os pais de um menino de 12 anos estão muito preocupados com a altura dele, uma vez que ele é o menor entre os seus colegas da escola. O médico que o atende explica que a velocidade de crescimento está diretamente relacionada ao estágio puberal e que o início do estirão dele deve começar quando

- A) houver aumento testicular.
- B) iniciar o aumento de comprimento peniano.
- C) o pênis começar a aumentar em largura.
- D) aparecer pilificação pubiana e axilar.
- E) ocorrer a espermaca.

47) Os episódios de síncope relatados em adolescentes após a vacinação contra o HPV são atribuídos a

- A) reação autoimune.
- B) choque cardiogênico.
- C) síndrome vasovagal.
- D) anafilaxia.
- E) acometimento neurológico.

48) Considerando o padrão esperado de ganho pômbero-estatural durante a infância e adolescência, é correto afirmar que:

- A) o perímetro cefálico de um lactente de 3 meses de idade deve estar 6 cm maior em comparação ao do nascimento.
- B) o peso de nascimento costuma duplicar aos 6 meses de idade.
- C) a fase de maior velocidade de crescimento ocorre durante o estirão puberal.
- D) a velocidade de crescimento esperada para um pré-escolar é de 10 a 12 cm/ano.

E) após a menarca, a menina não costuma crescer em altura, apresenta, apenas, ganho de peso e de índice de massa corpórea.

49) Considerando o desenvolvimento esperado por faixa etária, assinale a alternativa que apresenta a criança com atraso de aquisição de marcos.

A) Menina de 18 meses que não gosta de brincar com outras crianças.

B) Menino de 7 meses de idade que não segura a mamadeira.

C) Menina de 6 meses de idade que não bate palmas.

D) Menino de 16 meses sem controle esfinteriano.

E) Menina de 24 meses que não compreende ordem simples.

50) Lactente de 18 meses de idade é levado ao pronto-atendimento com história de um dia de rinorreia clara, tosse, rouquidão e febre de 38 °C que progrediram para desconforto respiratório, agitação psicomotora e piora do quadro febril. Ao exame, encontra-se em regular estado geral, agitado, febril (39 °C), taquicárdico, taquidispneico e com estridor inspiratório em repouso, sendo feito diagnóstico de crupe viral. Para a definição de gravidade, o médico deve levar em consideração:

A) a pontuação em escore clínico do grau de obstrução de vias aéreas.

B) a saturação de oxigênio em ar ambiente.

C) o grau de estreitamento subglótico verificado na radiografia cervical.

D) o grau de edema laringotraqueal verificado na laringoscopia direta.

E) a resposta terapêutica à inalação com epinefrina.

51) Menina de 5 anos de idade, vítima de atropelamento, dá entrada na sala de emergência com Glasgow = 13, cianótica, com pulsos finos, frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto, ventilando e saturando 90% em ar ambiente. A conduta inicialmente indicada é:

A) pegar acesso venoso para expansão volêmica.

B) oferecer oxigênio em cateter 2 L/min.

C) iniciar ventilação com ambu e compressões torácicas.

D) realizar desfibrilação.

E) administrar atropina.

52) Menina de 3 anos de idade, previamente hígida, é levada ao pronto-atendimento com história de 2 dias de prostração, febre de 39,5 °C e rash cutâneo, mais intenso na região perioral e em dobras, evoluindo com piora progressiva, com aparecimento de fissuras e crostas ao redor da boca, dos olhos e do nariz e bolhas na pele. Ao examiná-la, nota-se descolamento da pele com uma leve tração. Frente a essa descrição, a principal hipótese diagnóstica é:

A) epidermólise bolhosa.

B) eritema multiforme.

C) síndrome da pele escaldada estafilocócica.

- D) síndrome de Kawasaki.
- E) escarlatina.

53) Menina de 4 anos, previamente hígida, tem história de 3 dias de febre (38,5 °C), inapetência e um pouco de tosse. Hoje apresenta dor abdominal à direita e piora do estado geral, sendo levada ao pronto-atendimento. Ao exame, está em regular estado geral, pálida, afebril no momento, com frequência cardíaca de 110 bpm e frequência respiratória de 40 ipm. Ausculta pulmonar com redução do murmúrio vesicular à direita e exame abdominal doloroso, com tensão voluntária e redução dos ruídos hidroaéreos. Levando em consideração a principal hipótese diagnóstica, qual dos exames a seguir deve auxiliar a definir o diagnóstico?

- A) Leucograma com diferencial.
- B) Enzimas hepáticas séricas.
- C) Enema opaco.
- D) Tomografia computadorizada de abdome.
- E) Radiografia de tórax.

54) Na primeira consulta de puericultura de um recém-nascido, o pediatra verifica o teste do pezinho e identifica que a pesquisa de hemoglobinopatias revelou padrão FAS. Esse achado é compatível com:

- A) padrão fetal normal.
- B) traço falciforme.
- C) anemia falciforme.
- D) talassemia minor.
- E) hemoglobinopatia SC.

55) Adolescente de 15 anos de idade procura o pronto-atendimento com história de urina escura há 3 dias acompanhada de mal-estar geral, sem febre. Refere que há 2 semanas esteve em um sítio e recebeu várias picadas de inseto, que coçavam bastante, mas que melhoraram com o uso de anti-histamínico oral. Ao exame, está em bom estado geral, com discreto edema palpebral, frequência cardíaca de 90 bpm, frequência respiratória de 20 ipm, pressão arterial de 135 x 90 mmHg e lesões cicatriciais em membros inferiores. Esse quadro clínico é sugestivo de qual diagnóstico?

- A) Síndrome hemolítico-urêmica.
- B) Hepatite viral aguda.
- C) Uretrite gonocócica.
- D) Glomerulonefrite difusa aguda.
- E) Litíase renal.

56) Recém-nascido de 20 dias de vida, nascido a termo, de parto normal, sem intercorrências, é levado ao pronto-atendimento com história de um dia de febre (38,5 °C), irritabilidade, 2 episódios de vômitos e inapetência. Ao exame físico encontra-se irritado, choroso, febril, taquicárdico, taquipneico e com a fontanela abaulada, sem rigidez de nuca.

Restante do exame físico sem alterações. De acordo com a principal hipótese diagnóstica, a conduta inicialmente indicada é:

- A) prescrever antitérmico e terapia de reidratação oral.
- B) colher eletrólitos e fazer expansão com soro fisiológico 20 ml/kg.
- C) solicitar tomografia de crânio.
- D) realizar punção lombar e iniciar antibioticoterapia parenteral.
- E) colher hemograma, urina tipo I e proteína C reativa.

57) Menina com síndrome de Down diagnosticada ao nascimento é levada ao pronto atendimento com 10 dias de vida devido a desconforto respiratório. Ao exame, detecta-se taquidispneia, hepatoesplenomegalia e ausculta cardíaca com hipofonese de primeira bulha, desdobramento de segunda bulha e sopro cardíaco 4+/6. O pediatra solicitou um ecocardiograma na urgência, que provavelmente irá revelar

- A) persistência de canal arterial.
- B) transposição de grandes artérias.
- C) coarctação de aorta.
- D) defeito do septo atrioventricular.
- E) drenagem venosa anômala.

58) Menino de 1 ano de idade esteve hospitalizado há 1 mês devido à síndrome de Kawasaki, recebendo imunoglobulina durante a internação e alta com ácido acetilsalicílico em dose profilática. Retorna hoje para consulta de puericultura, assintomático. Além da solicitação de ecocardiograma controle, o pediatra deve ter preocupação especial

- A) ao realizar o exame abdominal.
- B) em solicitar dosagem de hemoglobina sérica.
- C) em contraindicar o retorno à creche.
- D) em solicitar coagulograma.
- E) em adiar as vacinas de vírus vivos programadas para os 12 meses de idade.

59) Estudos relacionados à importância do período periconcepcional para a saúde futura do indivíduo trouxeram diversas evidências sobre a importância dos primeiros 1000 dias. Nesse sentido, é correto afirmar que

- A) a deficiência materna de ácido fólico é associada a maior risco de malformações cardíacas fetais.
- B) a idade paterna avançada tem sido associada a maior risco de desenvolvimento de transtorno do espectro autista nos filhos.
- C) o índice de massa corpórea materna pré-gestacional pode afetar o peso de nascimento do conceito, mas não influencia o estado nutricional pós-natal.
- D) o padrão genético de um indivíduo é responsável por 80% da sua expressão fenotípica, dessa forma, uma mesma sequência de DNA produz sempre o mesmo fenótipo.

E) o estresse tóxico a que uma mãe é submetida durante a gestação pode afetar o desenvolvimento do conceito, sem repercussão nas gerações seguintes.

60) Adolescente de 15 anos vem à consulta, acompanhada por seu namorado de 17 anos, solicitando orientações em relação a métodos contraceptivos. Nessa situação, a prescrição de contraceptivos pelo médico é

- A) antiética, uma vez que, devido à diferença de idade entre eles, as relações sexuais podem ser consideradas estupro de vulnerável.
- B) proibida, uma vez que menores de 18 anos não têm autonomia legal.
- C) imprudente, pelo risco de efeitos colaterais indesejáveis antes de estar finalizado o estirão de crescimento da puberdade.
- D) aconselhável, sendo importante a verificação de consentimento entre ambos.
- E) permitida apenas após a autorização dos responsáveis legais.

61) A endometriose (EDT) parece não conferir risco aumentado para neoplasia, mas há, no entanto, evidências epidemiológicas e moleculares de sua associação com determinados tipos de câncer, principalmente os de ovário. Os mecanismos envolvidos permanecem pouco compreendidos, e a transformação maligna da endometriose parece ocorrer em cerca de 1% dos casos. Sobre a fisiopatologia da endometriose e câncer de ovário, assinale a alternativa correta.

- A) As neoplasias de ovário relacionadas à endometriose apresentam prognóstico menos favorável, com menores taxas de sobrevivência.
- B) As neoplasias de ovário relacionadas a endometrioses são diagnosticadas em estágios mais tardios, com tumores de graus mais elevados.
- C) O mecanismo da transformação da endometriose no câncer de ovário já é nitidamente compreendido.
- D) Endometriomas de grande volume e nodulações peritoneais não seriam fatores preditivos para câncer de ovário.
- E) Os subtipos de neoplasia ovariana com maior associação com EDT são tumor de células claras e endometrioides.

62) K.S.M., 20 anos, primigesta, vem ao pronto-socorro obstétrico com queixa de sangramento vaginal escuro, náuseas e vômitos, tontura e cefaléia fronto occipital. Realizado teste de gravidez positivo. Refere história de amenorreia de 3 meses anteriormente ao sangramento atual. Ao exame físico: volume uterino aumentado, com AU 20 cm, PA 160 x 110 mmHg, FC 85 bpm. Ultrassom transvaginal demonstra volume uterino de 400cc, eco endometrial heterogêneo, com espessura de 60 mm, com imagens císticas, anecogênicas de permeio. Não identificado embrião. Ovários com cistos teca- luteínicos. Com base no caso clínico e suspeita diagnóstica, assinale a conduta mais adequada, inicialmente.

- A) Expansão volêmica.
- B) Antieméticos.

- C) Metildopa.
- D) Beta HCG quantitativo.
- E) Sulfato de magnésio.

63) K.S.M., 20 anos, primigesta, vem ao pronto-socorro obstétrico com queixa de sangramento vaginal escuro, náuseas e vômitos, tontura e cefaléia fronto occipital. Realizado teste de gravidez positivo. Refere história de amenorreia de 3 meses anteriormente ao sangramento atual. Ao exame físico: volume uterino aumentado, com AU 20 cm, PA 160 x 110 mmHg, FC 85 bpm. Ultrassom transvaginal demonstra volume uterino de 400cc, eco endometrial heterogêneo, com espessura de 60 mm, com imagens císticas, anecogênicas de permeio. Não identificado embrião. Ovários com cistos teca- luteínicos. Controlado o caso clínico inicial, a paciente foi internada. Assinale a alternativa que representa a melhor técnica para o tratamento da patologia representada na imagem ultrassonográfica descrita.

- A) AMIU (aspiração manual intra-uterina).
- B) Curetagem uterina.
- C) Misoprostol via vaginal.
- D) Histerectomia.
- E) Ergotrate IM.

64) K.S.M., 20 anos, primigesta, vem ao pronto-socorro obstétrico com queixa de sangramento vaginal escuro, náuseas e vômitos, tontura e cefaléia fronto occipital. Realizado teste de gravidez positivo. Refere história de amenorreia de 3 meses anteriormente ao sangramento atual. Ao exame físico: volume uterino aumentado, com AU 20 cm, PA 160 x 110 mmHg, FC 85 bpm. Ultrassom transvaginal demonstra volume uterino de 400cc, eco endometrial heterogêneo, com espessura de 60 mm, com imagens císticas, anecogênicas de permeio. Não identificado embrião. Ovários com cistos teca- luteínicos. Dando prosseguimento ao atendimento, assinale a alternativa que representa orientação adequada de seguimento da paciente.

- A) Iniciar o seguimento pós-molar somente após o resultado anátomo patológico confirmar a doença.
- B) Repetir ultrassom 7 dias após o procedimento cirúrgico, a fim de avaliar a existência de resquícios da doença.
- C) Realizar o acompanhamento com dosagens mensais de hCG para detectar a ocorrência de neoplasia trofoblástica gestacional (NTG).
- D) Realizar contracepção hormonal rigorosa, uma vez que a pílula anticoncepcional não aumenta o risco de progressão para NTG.
- E) Rotina ginecológica anual.

65) A síndrome pré-menstrual (SPM) é um conjunto de mudanças físicas, emocionais e comportamentais recorrentes e cíclicas de intensidade moderada a grave que afeta as mulheres na menacme, com início durante a fase lútea e término durante a menstruação. Com relação à fisiopatologia da síndrome pré-menstrual, assinale a alternativa correta.

- A) A síndrome manifesta-se também em mulheres ooforectomizadas ou anovuladoras crônicas.
- B) As mulheres com síndrome pré-menstrual mais grave apresentam menores níveis de GABA, o que está associado a sintomas como ansiedade, nervosismo e agitação.
- C) Há associação entre sintomas depressivos da SPM e a diminuição de pulsos secretores de cortisol na fase lútea.
- D) A manifestação dos sintomas da SPM deve-se à queda de níveis de progesterona e de estradiol na segunda fase do ciclo menstrual.
- E) A SPM inicia-se na fase proliferativa, com término um pouco antes da menstruação.

66) A depressão é um diagnóstico comum na população em geral e tem uma prevalência marcadamente maior em mulheres. Em fases da vida da mulher como perimenopausa e período pós-parto há um risco maior de a mulher desenvolver transtornos de humor, bem como apresentar recaída de um transtorno preexistente. Com base nesse assunto, assinale a alternativa correta.

- A) Os antidepressivos como Citalopram, Escitalopram, Paroxetina, Venlafaxina, Desvenlafaxina e Duloxetina podem ser utilizados no tratamento dos sintomas depressivos no período pós-parto.
- B) O aparecimento dos sintomas depressivos no climatério está associado apenas a fatores psicossociais.
- C) Em pacientes no climatério, com sintomas vasomotores e contraindicação para o uso de estrogênios, o uso de antidepressivos é uma alternativa.
- D) Em mulheres em uso de Tamoxifeno, o antidepressivo de escolha é a paroxetina.
- E) Geralmente a depressão pós-parto inicia-se nas primeiras 2 semanas do parto.

67) As vulvovaginites, assim como todas as manifestações inflamatórias e ou infecciosas do trato genital feminino, constituem os problemas mais comumente observados em atendimento ambulatorial na ginecologia. Um micro- bioma vaginal desequilibrado é porta de entrada para infecções tanto do trato genital inferior quanto do superior. Sobre as vulvovaginites, assinale a alternativa correta.

- A) A Chlamydia trachomatis tem maior prevalência em mulheres com idade > 30 anos.
- B) A vaginite atrófica ocorre principalmente em mulheres na perimenopausa e está associada a baixos níveis de progesterona.
- C) A doxiciclina por 7 dias é o tratamento de escolha para Chlamydia, visto que há baixo índice de cura com dose única de Azitromicina.
- D) Secreção volumosa tipo leite coalhado, disúria inicial, prurido vulvar, dor, edema e hiperemia são compatíveis com quadro de vaginose bacteriana.
- E) Na vaginose bacteriana há perda de lactobacilos, pH > 4,5 e whiff- test positivo.

68) F.Z.P., 21 anos, GI PI 1N A0, vem ao PSO com queixa de dor pélvica há 2 dias. Dor de início em hipogástrio, estende para fossas ilíacas e lombar. Nega disúria. Refere piora da dor nas últimas 24 horas, sendo contínua, associada a discreto sangramento vaginal. Nega febre

aferida, nega alteração de hábito intestinal. Nega náuseas ou vômitos. Alega secreção vaginal acinzentada, fétida após relação sexual. Em uso regular de ACHO . Ao exame físico: FC 80 bpm, Tax 38o C, PA 100 x 70 mmHg. Abdome: dor à descompressão brusca negativa, ausência de massas ou tumorações. Dor a palpação profunda de hipogástrio e fossas ilíacas. Giordano negativo. Especular: conteúdo vaginal cinzentado e bolhoso, discreto sangramento pelo orifício externo do colo uterino. TV bimanual: dor à mobilização do colo e corpo uterino. Útero de volume normal. De acordo com o caso clínico, assinale a alternativa que representa o diagnóstico mais provável.

- A) Cistite.
- B) Pielonefrite.
- C) Apendicite.
- D) Gestação ectópica.
- E) Doença inflamatória pélvica aguda.

69) F.Z.P., 21 anos, GI PI 1N A0, vem ao PSO com queixa de dor pélvica há 2 dias. Dor de início em hipogástrio, estende para fossas ilíacas e lombar. Nega disúria. Refere piora da dor nas últimas 24 horas, sendo contínua, associada a discreto sangramento vaginal. Nega febre aferida, nega alteração de hábito intestinal. Nega náuseas ou vômitos. Alega secreção vaginal acinzentada, fétida após relação sexual. Em uso regular de ACHO . Ao exame físico: FC 80 bpm, Tax 38o C, PA 100 x 70 mmHg. Abdome: dor à descompressão brusca negativa, ausência de massas ou tumorações. Dor a palpação profunda de hipogástrio e fossas ilíacas. Giordano negativo. Especular: conteúdo vaginal cinzentado e bolhoso, discreto sangramento pelo orifício externo do colo uterino. TV bimanual: dor à mobilização do colo e corpo uterino. Útero de volume normal. Após se chegar ao diagnóstico mais provável, assinale a conduta correta.

- A) Doxiciclina + metronidazol VO+ ceftriaxona 250 mg IM.
- B) Internação para antibioticoterapia EV.
- C) Laparotomia exploradora por abdome agudo.
- D) Nitrofurantoína VO.
- E) Ceftriaxone EV por 7 dias.

70) A puberdade é um período dinâmico de crescimento físico, maturação sexual e transformação psicossocial. O desenvolvimento puberal é mediado por uma complexa interação de fatores inibidores e ativadores que atuam no eixo hipotálamo-hipófise- ovariano (HHO). Assinale a alternativa que representa o sinal clínico que primeiro surge, em decorrência da ativação do eixo HHO no início da puberdade fisiológica.

- A) Pubarca.
- B) Axilarca.
- C) Odor corporal.
- D) Menarca.
- E) Telarca.

71) R.A.P., 45 anos, HAS, diabética, iniciou uso de anel vaginal para anticoncepção há 4 meses, por conta própria, após cirurgia bariátrica restritiva (gastrectomia vertical). Há uma semana apresentando tosse, febre e dispneia. No pronto socorro foi hospitalizada para suporte respiratório. O RT PCR para SRS- CoV-2 veio positivo. Ao EF: IMC 28kg/m², PA 180 x 100 mmHg. TC de tórax com extenso comprometimento pulmonar bilateral. Paciente foi encaminhada para UTI. Com base no caso clínico, assinale a alternativa que representa a melhor conduta ginecológica.

- A) Orientar a manutenção do método contraceptivo vigente, pois a cirurgia bariátrica realizada reduz a absorção de métodos orais.
- B) Orientar a manutenção do método contraceptivo vigente, uma vez que a paciente não pode correr o risco de gestação devido à cirurgia bariátrica recente.
- C) Suspender o uso do anel vaginal e introduzir uma pílula de progestagênio isolado após a alta hospitalar.
- D) Suspender o uso do anel vaginal e introduzir, após a alta, o método anticoncepcional combinado oral.
- E) Dentre os possíveis métodos anticoncepcionais, o mais adequado após a alta da paciente é o injetável mensal.

72) G.M.A., 28 anos, GII PI 1N A0, IG 16 semanas, gestação única. Vem à primeira consulta de pré-natal. Descobriu gestação tardiamente, por sangramento irregular no início da gestação. Refere prematuridade prévia, com parto vaginal com IG 30 semanas. Nega outras comorbidades. Ao exame físico, AU compatível com 16 semanas de IG, BCF 150 bpm. Especular: conteúdo vaginal fisiológico, colo sem lesões aparentes. TV bimanual: colo impérvio, amolecido e posterior. Fundo uterino um pouco abaixo da cicatriz umbilical. De acordo com o caso acima, assinale a conduta mais adequada.

- A) Aguardar 20 semanas de idade gestacional pra medida única do colo uterino e conduta posterior.
- B) Progesterona via vaginal e medida seriada do colo uterino com IG entre 16-24 semanas.
- C) Cerclagem uterina.
- D) Pessário cervical.
- E) Iniciar progesterona e suspender se após ultrassom transvaginal medida do colo uterino for > ou igual a 25 mm.

73) R.C.T., 30 anos, GII PI 1N A0, IG 33 semanas, refere palpitações, principalmente quando faz exercícios, como andar um pouco mais rápido, ou subir um lance curto de escadas, com piora progressiva nas duas últimas semanas. Paciente refere que acorda à noite com falta de ar, principalmente quando dorme em posição supina. Nega doenças prévias. Refere sedentarismo antes de engravidar. Ao exame físico: paciente em bom estado geral, corada, hidratada, anictérica e acianótica. PA 120 x 80 mmHg. Ausculta cardiovascular: RCR, 2T, sopro sistólico +/6+ em foco aórtico acessório. Identificado edema em membros inferiores +/4+.

Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.

- A) Alterações gravídicas normais.
- B) Insuficiência cardíaca congestiva.
- C) Estenose mitral severa.
- D) Estenose aórtica reumática.
- E) Anemia aguda.

74) D.P.S., 29 anos, primigesta, IG 9 semanas e 4 dias, veio à consulta de pré-natal para mostrar exame laboratorial colhido há 1 semana. Glicemia de jejum de 92 mg/dL. De acordo com o caso acima, assinale o diagnóstico e/ou conduta corretos.

- A) Trata-se de diabetes gestacional.
- B) Deve-se repetir glicemia de jejum, para que a paciente traga na próxima consulta, a fim de confirmação diagnóstica.
- C) Deve-se solicitar TOTG (teste oral de tolerância à glicose) com IG 24-28 semanas.
- D) Deve-se solicitar hemoglobina glicada e insulina para complementação diagnóstica.
- E) Trata-se de overt diabetes.

75) M.G.A., 23 anos, idade gestacional cronológica de 8 semanas, procura a medicina fetal para ultrassom obstétrico inicial. As imagens demonstram útero em anteversão, contornos regulares. Identificado saco gestacional intrauterino, com diâmetro médio de 8 mm. Não identificado embrião no interior do saco gestacional. Não identificados sinais de descolamento ovular. Paciente sem queixas. De acordo com o caso acima, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de gestação anembrionada.
- B) Deve-se repetir o ultrassom em cerca de 7-14 dias para controle evolutivo.
- C) Trata-se de ameaça de abortamento.
- D) Com essa medida de saco gestacional, já deveria ser visibilizada a vesícula vitelínica.
- E) A idade gestacional pelo ultrassom está compatível com a idade gestacional cronológica.

76) P.N.B., 33 anos, primigesta, IG 8 semanas pela DUM, deu entrada no PSO com dor abdominal de início súbito, referindo sangramento vaginal em pequena quantidade há cerca de 4 dias. Nega comorbidades. Nega história de trauma. Ao exame físico: PA 90 x 60mmHg, hipocorada +/4+, FC 105 bpm, abdome: dor à descompressão brusca positiva. Especular: sangramento vermelho escuro em pequena quantidade exteriorizando pelo orifício externo do colo uterino. Toque vaginal bimanual: dor à mobilização do colo. Realizado ultrassom point of care pela emergência e identificada grande quantidade de líquido livre em cavidade pélvica. Assinale a alternativa que representa a primeira suspeita diagnóstica.

- A) Mola hidatiforme.
- B) Aborto retido.
- C) Aborto incompleto.

- D) Gestação ectópica rota.
- E) Gestação heterotópica.

77) P.N.B., 33 anos, primigesta, IG 8 semanas pela DUM, deu entrada no PSO com dor abdominal de início súbito, referindo sangramento vaginal em pequena quantidade há cerca de 4 dias. Nega comorbidades. Nega história de trauma. Ao exame físico: PA 90 x 60mmHg, hipocorada +/-, FC 105 bpm, abdome: dor à descompressão brusca positiva. Especular: sangramento vermelho escuro em pequena quantidade exteriorizando pelo orifício externo do colo uterino. Toque vaginal bimanual: dor à mobilização do colo. Realizado ultrassom point of care pela emergência e identificada grande quantidade de líquido livre em cavidade pélvica. Após a confirmação diagnóstica do caso clínico, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) Laparoscopia.
- B) Laparotomia exploradora.
- C) AMIU.
- D) Curetagem uterina.
- E) Metotrexate IM.

78) R.D.B., 35 anos, GIV PII 2N AI, IG 34 semanas, HIV positivo, com carga viral 700 cópias/ml, CD4: 400, em uso de TARV, deu entrada no PSO com queixa de perda de líquido há 30 minutos. Alega dor tipo contração uterina. Ao toque vaginal: colo uterino de 7 cm, médio, posterior, apresentação cefálica, DU 3/10"/40". Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) Zidovudina (AZT) dose de ataque e cesárea de urgência.
- B) Condução do trabalho de parto com ocitocina EV, Ampicilina dose de ataque e manutenção.
- C) Zidovudina (AZT) e Ampicilina, ambos EV, na dose de ataque e manutenção.
- D) Inibição do trabalho de parto com Terbutalina.
- E) Corticoide, Sulfato de Magnésio, Ampicilina EV e Zidovudina VO.

79) T.D.L., 34 anos, GIV PIII 2N 1C A0, IG 34 semanas e dias, HAC, em uso de Metildopa 1g/dia. Deu entrada no PSO com queixa de cefaléia occipitofrontal, dor epigástrica e náuseas. PA 150 x 100 mmHg. Sem queixas obstétricas. Solicitados exames laboratoriais na urgência: ácido úrico de 8, DHL 700, Hb 11, TGO 30, TGP 22, Ur 30; Cr 1,0, plq: 130.000. Relação proteína na urina/ creatinina na urina de 0,3. Ultrassom obstétrico com doppler: feto único e vivo, apresentação cefálica, BCF 150 bpm, MBV (maior bolsão vertical): 3,0 cm, peso fetal no percentil 2, doppler de artéria umbilical com diástole zero, ducto venoso normal. Perfil biofísico fetal 8/10 (perda nos movimentos respiratórios). De acordo com o caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.

- A) Eclâmpsia.
- B) Pré-eclâmpsia.
- C) Pré-eclâmpsia superajuntada.

D) Hipertensão gestacional.

E) Síndrome HELLP.

80) T.D.L., 34 anos, GIV PIII 2N 1C A0, IG 34 semanas e dias, HAC, em uso de Metildopa 1g/dia. Deu entrada no PSO com queixa de cefaléia occipitofrontal, dor epigástrica e náuseas. PA 150 x 100 mmHg. Sem queixas obstétricas. Solicitados exames laboratoriais na urgência: ácido úrico de 8, DHL 700, Hb 11, TGO 30, TGP 22, Ur 30; Cr 1,0, plq: 130.000. Relação proteína na urina/ creatinina na urina de 0,3. Ultrassom obstétrico com doppler: feto único e vivo, apresentação cefálica, BCF 150 bpm, MBV (maior bolsão vertical): 3,0 cm, peso fetal no percentil 2, doppler de artéria umbilical com diástole zero, ducto venoso normal. Perfil biofísico fetal 8/10 (perda nos movimentos respiratórios). De acordo com o caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

A) Cesárea de emergência.

B) Sulfato de magnésio dose de ataque e manutenção para estabilização da paciente e cesárea na sequência.

C) Sulfato de magnésio dose de ataque e manutenção, hidralazina EV e indução do trabalho de parto com ocitocina.

D) Sulfato de magnésio dose de ataque e manutenção e preparo do colo uterino com sonda de Foley.

E) Sulfato de magnésio dose de ataque e manutenção, hidralazina EV e controle diário de ducto venoso até idade gestacional de 35 semanas.

81) O aleitamento materno é considerado fundamental para a saúde das crianças. Assinale a alternativa correta sobre esse tema.

A) O aleitamento materno até os 6 meses de idade relativiza a importância da vacinação até essa idade.

B) O leite materno protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias e deve ser o alimento exclusivo até os 6 meses de idade.

C) As mamadas devem ocorrer a cada 4 horas de forma que o bebê esteja com fome e aceite o leite com mais vontade.

D) Nos primeiros 6 meses, a mamadeira deve ser usada somente para água e chá, sem oferta de leite não materno.

E) Como o leite materno contém alto teor de gordura no final da mamada, é recomendado que deve haver troca de peito antes do esvaziamento, para que o bebê não fique obeso.

82) Assinale alternativa correta sobre o tabagismo.

A) A proibição do uso de cigarros, cigarrilhas charutos ou qualquer outro produto fumígeno em recinto fechado, privado ou público é determinada somente por leis estaduais.

B) A fumaça que sai da ponta do cigarro e se difunde homoganeamente no ambiente, contém em média três vezes menos nicotina, três vezes menos monóxido de carbono, mas até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que o fumante inala.

C) A nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma droga psicoativa que causa dependência, age no sistema nervoso central e chega ao cérebro em 7 a 19 segundos, aproximadamente.

D) Tabagismo passivo é a inalação da fumaça de derivados do tabaco, tais como cigarro e charuto, ficando de fora as cigarrilhas, o cachimbo e o narguilé, por indivíduos não fumantes, que convivem com fumantes em diferentes ambientes.

E) Comprovadamente o tabagismo passivo de crianças e gestantes não tem consequências para a saúde.

83) De acordo com o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) de 2017, a prevalência de hipertensão autorreferida passou de 22,6% em 2006 para 24,3% em 2017. Assinale a alternativa correta sobre essa temática.

A) A pressão alta tende a aumentar com a idade.

B) A atenção primária da saúde (APS) tem papel pouco significativo no diagnóstico de hipertensão arterial.

C) O diagnóstico de hipertensão arterial é complexo e requer assistência especializada.

D) A hipertensão gestacional é frequente, mas não é causa de mortalidade materna.

E) A principal forma de prevenir a hipertensão arterial é manter o peso na normalidade.

84) Assinale a alternativa correta sobre os princípios da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).

A) A intrasetorialidade diz respeito ao exercício permanente da desfragmentação de ações e serviços ofertados por um setor, e ao mesmo tempo às especificidades para que atribuições entre os órgãos não se sobreponham causando conflitos desnecessários.

B) A autonomia se refere à identificação de potencialidades e ao desenvolvimento de capacidades em cada território por parte dos gestores municipais e estaduais, independentemente da determinação federal.

C) A corresponsabilidade se refere a responsabilidades partilhadas entre pessoas ou coletivo e a gestão dos serviços do SUS, com pesos iguais.

D) A territorialidade diz respeito à divisão geográfica para o planejamento e desenvolvimento de ações intrasetoriais, considerando as principais necessidades da população circunscrita e a verba disponível.

E) O empoderamento se refere ao processo de intervenção que estimula os sujeitos e coletivos a adquirirem o controle das decisões e das escolhas de modos de vida adequado às suas condições sócio-econômico-culturais.

85) Um grupo de pesquisadores tem uma suspeita sobre a causa do aumento de uma determinada doença crônica em uma região nos últimos 10 anos. Assinale a alternativa correta sobre esta questão.

- A) Um estudo transversal permitiria estimar a incidência de casos e assim, confirmar ou não a suspeita inicial, com relativo baixo custo.
- B) Embora de desenho complexo, um estudo de coorte seria indicado nesse caso, pelo baixo custo relativo e a possibilidade de obtenção de resultados em curto prazo.
- C) Tanto um estudo de caso-controle como o de coorte poderiam ser desenvolvidos, mas o de coorte seria de mais fácil execução, com menos perdas de participantes.
- D) Um estudo caso-controle permitiria obter a razão dos produtos cruzados (odds ratio) e confirmar ou não a suspeita inicial, com relativo baixo custo.
- E) Um estudo ecológico envolvendo vários municípios semelhantes seria o único a permitir a confirmação ou não da suspeita inicial de forma adequada.

86) A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. Assinale a alternativa que contém condições que favorecem o aumento de casos da doença.

- A) Tempo seco e calor.
- B) Chuva e calor.
- C) Ratos e chuva.
- D) Frio e proximidade física entre pessoas.
- E) Aglomerações humanas e ratos.

87) Assinale a alternativa correta sobre aspectos do Papilomavírus Humano (HPV).

- A) A medida mais eficaz contra o HPV é a vacinação.
- B) O exame Papanicolau previne o HPV.
- C) Pessoas com transplantes de órgãos sólidos não devem ser vacinadas contra o HPV.
- D) O uso de preservativo previne o HPV totalmente.
- E) O tratamento das verrugas anogenitais decorrente do HPV deve ser cirúrgico.

88) A equipe de uma unidade básica de saúde (UBS) atende jovens entre 13 e 17 anos de idade com pequenas queimaduras nas pernas e nas mãos. Trabalham em uma pequena empresa que fabrica bijuterias e trabalham na montagem das peças usando pequenos soldadores, para fundir partes metálicas, que acabam causando as queimaduras. Assinale a alternativa correta sobre a notificação dos casos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

- A) Apenas as queimaduras dos jovens com mais de 14 anos devem ser registradas como acidentes de trabalho.
- B) Apenas os jovens formalmente registrados como empregados da empresa devem ter seus ferimentos registrados como acidentes de trabalho.
- C) Todas as queimaduras citadas são decorrentes do trabalho e devem ser notificadas como acidentes de trabalho.
- D) Apenas caso o empregador não forneça equipamentos de proteção individual, os ferimentos devem ser registrados como acidentes de trabalho.

E) As notificações devem se restringir aos casos que requeiram afastamento do trabalho temporariamente para cicatrização.

89) A equipe de uma unidade básica de saúde (UBS) atende jovens entre 13 e 17 anos de idade com pequenas queimaduras nas pernas e nas mãos. Trabalham em uma pequena empresa que fabrica bijuterias e trabalham na montagem das peças usando pequenos soldadores, para fundir partes metálicas, que acabam causando as queimaduras.

Em relação a procedimentos para prevenção de novos casos de queimaduras na empresa, assinale a alternativa correta.

A) A UBS deve enviar uma carta com a lista dos jovens solicitando à empresa providências para que novos casos não mais ocorram.

B) A UBS deve notificar os conselhos tutelares para que atuem de forma a prevenir novos casos.

C) A UBS deve orientar os jovens para prestarem mais atenção no trabalho para que novos casos não ocorram.

D) A UBS deve aconselhar os jovens a procurarem a polícia para denunciar o que acontece na empresa.

E) A UBS deve se comunicar com o órgão de vigilância em saúde para que seja feita uma investigação das condições de trabalho na empresa.

90) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado na Constituição Federal, em 1988. Assinale a alternativa correta sobre a temática.

A) O SUS vem se consolidando ano a ano desde 1988, com aporte de recursos financeiros, mas sofre de um problema crônico de gestão ineficiente.

B) O SUS é inspirado no modelo da história natural da doença.

C) A criação do SUS foi resultado de uma articulação entre partidos políticos e sindicatos médicos.

D) O SUS foi inspirado na Reforma Sanitária e representa a vitória do conceito de que a saúde é determinada socialmente.

E) O SUS representa uma revolução setorial importante e conta apenas com os serviços públicos.

91) Quando Oswaldo Cruz foi nomeado para a Diretoria Geral de Saúde Pública em 1903, a febre amarela era o principal problema sanitário da capital federal. Só em 1902, quase mil pessoas morreram na cidade vitimadas pela doença. No início de 1907, já não se falava mais de epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz cumpria a sua promessa. Em março daquele ano, ele pôde, enfim, escrever ao presidente Afonso Pena: "graças à firmeza e vontade do governo, a febre amarela já não mais devasta sob a forma epidêmica a capital da República". Assinale a alternativa correta.

A) Oswaldo Cruz era adepto da teoria dos miasmas.

- B) Oswaldo Cruz criou um bônus financeiro para quem se vacinava.
- C) Oswaldo Cruz se concentrou em eliminar focos de mosquitos.
- D) Oswaldo Cruz vacinou toda a população.
- E) Oswaldo Cruz acreditava que a doença era transmitida de pessoa a pessoa.

92) Dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2006 a 2021 mostram que foram observados aumentos da frequência de excesso de peso em todas as faixas de idade e em todos os níveis de escolaridade. Em relação às faixas de idade, os maiores aumentos foram observados entre adultos de 25 a 44 anos, variando de 37,5%, em 2006, a 54,4%, em 2021 (1,12 pp/ano), para aqueles entre 25 e 34 anos; e de 48,8% a 62,4% (1,08 pp/ano) para aqueles entre 35 e 44 anos. Uma prefeitura de uma grande cidade vê que esses dados refletem o seu território e resolve atuar para mudar essa situação. Assinale a alternativa que contém medidas corretas a serem tomadas, entre outras.

- A) Incentivo às feiras livres venderem verduras, legumes e frutas a preços menores e promover a cultura do exercício físico em diferentes espaços.
- B) Estímulo aos supermercados para venderem produtos de fácil elaboração, como os pré-cozidos e aos clubes esportivos para promoverem competições de alto desempenho.
- C) Estímulo para o consumo em restaurantes de alimentos naturais e às corridas na região central da cidade.
- D) Incentivo aos supermercados para venderem produtos alimentícios de baixa caloria e às corridas nas diferentes regiões da cidade.
- E) Estímulo à população para que consuma produtos dietéticos e à realização de jogos coletivos nos clubes esportivos.

93) Assinale a alternativa correta sobre o coeficiente de mortalidade neonatal em uma determinada área durante o ano.

- A) Refere-se a óbitos de crianças entre 28 dias de vida até o 12º mês.
- B) É sinônimo de coeficiente de mortalidade pós-neonatal.
- C) Trata-se de um indicador muito usado, pois não exige o número de nascidos vivos.
- D) Refere-se a óbitos de crianças menores de 28 dias.
- E) O Brasil não dispõe desse coeficiente.

94) Assinale a alternativa correta sobre o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica no SUS.

- A) O acesso universal se restringe a medicamentos para hipertensão arterial.
- B) Secretarias estaduais de saúde podem estabelecer regras diferenciadas do acesso a medicamentos da relação nacional de medicamentos essenciais.
- C) Uma condição necessária, mas não suficiente é o usuário estar sendo assistido por ações e serviços de saúde do SUS.

D) Basta o usuário ter uma prescrição por profissional de saúde devidamente regularizado no seu conselho de classe.

E) O usuário tem direito a qualquer medicação.

95) Assinale a alternativa que contém pessoas que devem fazer profilaxia pré-exposição ao vírus da raiva.

A) Turistas de cavernas em geral.

B) Donos de cães.

C) Pessoas em situação de rua.

D) Médicos veterinários.

E) Pessoas que andam muito pelas ruas.

96) Em uma cidade de médio porte, em algumas UBS são atendidas, em um dia, pessoas com quadro gastrointestinal agudo em número bem maior de que o habitual. Na anamnese, descobre-se que a maioria delas esteve em uma grande festa de casamento. Assinale a alternativa correta.

A) Deve se tratar de uma epidemia de fonte persistente.

B) O caso tem características de uma epidemia explosiva por fonte comum.

C) Trata-se de uma epidemia progressiva.

D) As características são de uma epidemia lenta.

E) Não se pode caracterizar o caso como epidemia.

97) A partir de usuário com suspeita de intoxicação por chumbo, a vigilância em saúde vai a uma empresa fiscalizar as condições de trabalho. Encontra um ambiente único com algumas fontes de fumos de chumbo. Após exames verifica que 70% dos trabalhadores estão intoxicados. Assinale a alternativa correta.

A) Todos os casos de intoxicação pelo metal em questão devem ser notificados no Sinan como intoxicação ocupacional por chumbo.

B) Intoxicação crônica por chumbo não pode ser considerada relacionada ao trabalho.

C) Os casos podem ser notificados no Sinan como intoxicação ocupacional por chumbo, se os trabalhadores forem formalmente contratados.

D) Intoxicação por chumbo não é caso de notificação no Sinan.

E) Os casos devem ser notificados como intoxicações ocupacionais por chumbo, se a empresa não oferecer máscaras protetoras.

98) O pé diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo. Assinale a alternativa correta sobre este tema.

A) O exame periódico dos pés das pessoas com diabetes mellitus, que pode identificar precocemente as alterações, permitindo o tratamento oportuno e evitando o desenvolvimento de complicações, deve ser feito em unidades especializadas.

B) Entre as complicações crônicas do diabetes mellitus, a ulceração e a amputação de extremidades, que são complicações do pé diabético, são algumas das mais graves de maior impacto socioeconômico e são inevitáveis.

C) O pé diabético pode ser neuropático, vascular ou isquêmico e misto, mas as características do quadro clínico são as mesmas, assim como a evolução.

D) Denomina-se pé diabético a presença de infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos profundos associados a anormalidades neurológicas e a vários graus de doença vascular periférica em pessoas com diabetes mellitus.

E) A abordagem educativa das pessoas com diabetes mellitus tem pouca importância para a prevenção da ocorrência de ulcerações nos pés.

99) Assinale a alternativa correta sobre as conferências nacionais de saúde.

A) São ordinariamente convocadas pelo Conselho Nacional de Saúde.

B) Têm forte participação dos partidos políticos.

C) A proporcionalidade entre os segmentos a comporem a bancada de delegados é de 50% de gestores e 50% divididos entre usuários e trabalhadores da saúde.

D) O regimento é definido pelo Ministério da Saúde.

E) Há etapas preparatórias nos municípios e estados, dentre outras.

100) Assinale a alternativa correta sobre as pandemias da gripe espanhola, da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e da Covid-19.

A) No início, a AIDS era conhecida como a doença dos homossexuais, dos usuários de drogas injetáveis e dos hemofílicos.

B) A gripe espanhola começou na Espanha.

C) A AIDS é transmitida da mesma forma que a Covid-19.

D) Os tempos de disseminação das referidas pandemias foram semelhantes.

E) As desigualdades sociais pouco influenciaram no comportamento e evolução da AIDS nas populações.

GABARITO

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
A	C	C	D	C	C	E	C	B	C
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
D	A	E	B	C	C	E	B	C	A
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
B	D	B	E	D	E	A	A	A	D
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
C	B	D	B	A	B	D	A	E	C
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
E	E	E	C	E	D	B	B	D	D
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
A	A	E	A	B	D	C	D	B	B
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
C	B	D	D	C	D	E	B	A	A
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
B	C	C	C	A	E	E	C	C	D
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
D	D	A	B	E	B	A	C	E	E
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
E	E	A	A	A	D	E	B	D	A